EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 82134
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-04-09 08:48:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN FRANCISCO HERNANDEZ SEPULVEDA			RUN	: 3.767.265-3
F.Nac	: 23-01-1938	Edad	: 86 AÑOS, 2 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: CALLE PUELMA # 509 *SIN INFO **			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 233031		
Fecha Ingreso	: 2024-03-11	Fecha Egreso	: 2024-04-09 08:48:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) ACV territorio estriatocapsular derecha PH2
2) Hipojkalemia leve
3) Neumonia aspiratoria 2° a SAMS en vias de compensacion
4) Rectorragia (antec de MMT multiples)
5) ANemia moderada
6) HTA
7) DM2 NIR
8) Ca rectal no op con RT paliativa
9) Ca prostatico en hormonoterapia
10) Dependencia severa ABVD
11) FA sin TACO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Pacietne con antec descritos, consultra en SU el 11/03 por cuadro de desviacion de comisura labial, paresia BC izquierda. Se decide evaluacion por codigo ictus en SU, quien destaca deficit motor izquierdo, TAC de encefalo con posible lesion isquemica vs tumoral ganglionar derecha con trasnformacion hemorragica. En vista de contexto de paciente, se decide manejo conservador. Se decide ingreso para manejo. Evaluado por neurologia, quien decide completar estudio con eco TT y CSB se inicia terapia ATB por parametros inflaamatorios elevados. SE decide limitacion de tratamiento por comorbildiades y funcionalidad. Durante estancia se suma abundate hipersecrecion bronquial, manejada con aspiracion de secreciones segun demanda. Cultivos con desarrollo de S aureus , se identeifica foco de neumonia aspirativa, se rota terapia ATB a tazoman + cloxacilina. Posterior se cambia a cefadroxilo para completar en total 15 dias de terapia.
Desde el punto de vista persiste hpersecretor, con requeirmientos fluctuantes de dicho procedimiento. Se decide apoyar con maquina de aspiracion en conjunto de rehabilitacion kinesiologica

Paciente estable dentro de su condicion, sin requerimiento de aspiracion acorde a relato de personal en estas ultimas 24 hrs, sin requerimiento de O2 suplementario en estas ultimas 24 hrs, diuresis 300 cc en 24 hrs, actualmente recibiendo alimentacion via SNG. Desde postrados se entrega maquina de aspiracion, se educa a familiares respecto a su uso

Ex fisico -> Sopor superficial, no sigue ordenes, mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+)crepitantes bibasales, de predominio a izquierda

Extremidades sin edema, sin signos de TVP

Actualmente cursando su dia N° 22 hospitalizado, dia N° 8 de cefadroxilo, en condiciones de continuar terapia rehabilitadora via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Con cifras tensionales en limite normal bajo, se procedera a ajuste para evitar riesgo de hipotension
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Respiratorio: En vista de impoisbilidad de asegurar maximo dos aspiraciones diarias, se procedio a conseguir maquina de aspiracion para edeucacion a familiares al respecto, sumado a terapia rehabilitadora por parte de KNT; se procedera a continuar manejo via HODOm
4) Infeccioso: Se procedera a mantener terapia ATB con cefadroxilo por 10 dias, se solicitaran parametros inflamatorios dentro de 48 hrs

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentado 30°
2. Regimen fresubin a 40 cc/hr por SNG
3. Bisoprolol 2,5 mg, 2 comp c/12 hrs por SNG por 5 dias
4. Tramadol 50 mg, medio comp c/8hrs por SNG por 5 dias
5. Losartan 50 mg 1-0-0,5 por SNG por 5 dias
6. Bromuro de ipratropio 4 puff c/4 hrs por AC
7. Metolazona 2,5 mg al dia por SNG por 5 dias
8. Espironolactolna 25 mg, medio comp al dia por SNG por 5 dias
9. Cefadroxilo 250 mg/5cc; 20 cc c/12 hrs por SNG por 2 dias
10. DIgoxina 0,25 mg al dia por SNG por 5 dias
11. Paracetamol 500 mg, 1 comp c/8hrs por SNG SOS por 5 dias
12. Omeprazol 20 mg, 2 comp al dia por SNG por 5 dias
13. Cuidadods de enfermeria prevencion UPP
14. KNT motora y respiratoria dos veces al dia
15. Aspiracion de secreciones SOS
16. Pendiente evaluacion para maquina de aspiracion
17. CSV c/6hrs

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO